جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : جمال الدين احمد محمود صقر
المحافظة : الاسكندريه **الحي / المدينة :** اللبان **العنوان :** ئ~
رقم البطاقة : 25304260102692 **رقم التليفون :** 01020064610 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 11-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 26-04-1953 **المهنة :** سروجي

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : ورم خبيث بالبروستاتا
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : ورم خبيث بالبروستاتا
خطة العلاج : أورام كيماوي العلاج المساعد لوقاية العظام للمرضي الذين يتلقوا علاج هرموني حمض الزيلودرونيك [14157] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: جمال الدين احمد محمود صقر
National ID: 25304260102692

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

A patient of prostate cancer for Zoledronic acid for bone protection during hormonal therapy

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



National ID – Front
[[DOCTYPE:ID_FRONT]]



National ID – Back

[[DOCTYPE:ID_BACK]]

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPTS

Date Of Submission: ٩-١٦

Date Of MDT: 09/16/2026 16:57:11

Medical Report

Patient Name :	جمال الدين أحمد محمود صقر	**Age :**	73 Y
Sex :	○ Male ○ Female	**Comorbidity :**	HTN, HCV treated
ID No. :	25304260102692	**Telephone :**	01223373447
Family History :	13852	**Marital Status :**	◉ Married ○ Divorced ○ Single
Menopausal Status :	01020064610	**Reason of MDT :**	metastatic
		MDT name::	

Medical Report

Diagnosis : mHSPC

Notes :

73 years old, HTN, HCV treated by DAA, Ex smoker
Prostatic cancer in 2021, biopsied, adenocarcinoma Gleason 9, Received RT + ADT 3 years then stopped
PSA rise to 6.3
PET PSMA: PSMA avid prostatic enlargement + Regional LN, HFL, + bony lesions.
?For MDT

History:

Investigations:

Recommendations: ADT + Abiraterone acetate

MDT DECISION: MHSPC for starting ADT + ERLEADA
ZOMETA/3M

Specialty	Surgery	Pathology	Radiology

Non-UHIA Letter
[[DOCTYPE:NON_UHIA_LETTER]]

Patient's Name: Gamal Eldin Ahmed Mahmoud
Patient's ID: 1_134583 **Date:** 24/08/2026

Whole Body 18F-PSMA PET/CT Scan

Clinical question:

- 72-year-old gentleman with prostate cancer {PSA Total =6.3}, received radiotherapy.
- PET/CT is requested for current status evaluation and metastatic work-up.

Procedure:

- Whole-body PET/CT scan was done 30 min after I.V. injection of 6 mCi 18F-PSMA.
- CT images without contrast done for attenuation correction and an anatomic localisation was obtained followed by PET images from the vertex of the skull to the calf, in the transaxial, coronal and sagittal planes.
- The Standardised Uptake Value, maximum variant (SUV max) was calculated within regions of interest whenever needed.

Findings:

Prostate and true pelvic LN.s:

- **Enlarged prostate with heterogeneously increased PSMA uptake involving focal lesions, most active within the right posterior zones with SUVmax ~ 11.5.**
- **Few small bilateral prominently external iliac lymph nodes with variable degrees of PSMA uptake are seen, for reference:**
  - ✓ **The largest and most active one is seen at the right external iliac group, measuring ~ 1.1 x 0.7 cm with SUVmax ~ 14.7.**
  - ✓ **Small PSMA-avid one is seen nearly adherent to the proximal portion of left external iliac artery, measuring ~ 0.9 x 0.6 cm with SUVmax ~ 4.96.**

Head and neck:

- The brain looks normal with no abnormal focal tracer activity.
- No enlarged or dense tracer fixing cervical or supraclavicular LN.s.
- Normal physiological tracer uptake pattern is seen at soft tissues, glandular structures, oropharynx, larynx and salivary glands.
- Right maxillary sinus retention cyst.

Chest:

- Bilateral pulmonary reticulations and thin atelectatic bands; likely inflammatory sequel.
- Otherwise, no lung nodules, masses or parenchymal infiltrates.
- No pleural or pericardial effusion.
- No metabolically active or enlarged axillary, supra-clavicular, hilar or mediastinal lymph nodes could be detected.
- Normal tracer distribution over the myocardium.
- Bilateral elastofibroma dorsi.

Abdomen and pelvis:

- No adenopathy or nodal hypermetabolism at the abdomen.

- **Mildly enlarged liver with few hypodense focal lesions:**
  - ✓ **The most prominent one is seen within segment VI with relatively increased PSMA uptake, measuring ~ 1.5 x 2 cm with SUVmax ~ 27.2.**
  - ✓ **Another prominent centimetric hypodense one within segment IVb posterior sub-capsular aspect with relatively less PSMA uptake.**
- Normal CT of the spleen, pancreas, kidneys (apart from few left simple cortical cysts), adrenals and UB.
- No enlarged or dense tracer fixing abdominal LN.s.
- No ascites.
- Bilateral fat containing oblique inguinal hernia.

Musculoskeletal:

- **Small sclerotic osseous lesions involving the lesser trochanteric region of left femur and posterior aspect of both iliac bones with no significant PSMA uptake.**
- Otherwise, no significant PSMA-avid blastic or lytic osseous lesions allover the rest of the surveyed skeleton.

Impression:

Whole body (18F-PSMA) PET/CT is showing:

- **Enlarged prostate with heterogeneously increased PSMA uptake within parenchymal focal lesions as described, for better mpMRI data correlation.**
- **Few PSMA-avid regional lymph nodes.**
- **Few hepatic hypodense focal lesions with variable PSMA uptake.**
- **Few small sclerotic osseous lesions involving left femur and both iliac bones with no significant PSMA uptake.**

Best regards,

Dr. Yasser Elbedewy
Nuclear Medicine

Dr, Moumen Katamesh, MSc
Nuclear Medicine Specialist

Head of the department
Dr. Sherif Elfateh, MD
Nuclear Medicine

xx

البـــرج
معامل و سكان

Visit No.:	42026503965	Patient Name:	الاستاذ / جمال الدين أحمد محمود	Patient ID:	161624527
Visit Date:	08 Apr 2026	Branch :	B-Hadayek Helwan	Age / DOB:	71 year / 01 Jan 195
Receipt No.:	4529	Ref. Doctor:	ياسر محمد	Result Date:	09 Apr 2026
Payment Date:	08-04-2026 15:52:35	Customer:	نسله مصر	Insurance No	1111

Item Type	Item Name	Value	Result Date
Test	Calcium	137.5	09 Apr 2026
Test	Albumin	100	09 Apr 2026
Test	ionized Ca++	200	09 Apr 2026

Current Receipt Amount:	437.5	Discount:	0
Payment User Name:	محمد جمال مزيد	Final Amount:	437.5
Payment Date Time:	4/8/2026 3:52:38 PM	Total Received:	437.5
		Balance Amount:	0

اجمالي المبلغ المدفوع : 437.5 جنيها

User ID : user_1B613624527
Password : ADCDE975

يتم تسوية حساب التحويلات خلال سبعة أيام من هذا الإيصال وذلك كحد أقصى يسقط بعده حق المطالبة باسترداد المبلغ وفي حالة التسويه يلتزم العميل باحضار التالي (خطاب التحويل - صورة البطاقة الشخصية للمريض او للوالد في حالة الطفل - هذا الإيصال)

لاستفساراتكم وخدمة الزيارة المنزلية وتوصيل النتائج اتصل بخدمة العملاء من اي تليفون على - **19911**

أستلام النتائج من اى فرع من فروع معامل البرج او من خلال الموقع الإلكتروني مجانا **https://www.alborglab.com/web/alborg-lab/eservices#/results**

كما يمكنكم ايضا أستلام النتائج عن طريق تحميل تطبيق - **(البرج لاب - Alborg Lab)**

العنوان : شارع خالد بن الوليد امام محكمه الاسره 18
تليفون : 23764326 - 23764325 - 01159433226

استلامكم لهذا الإيصال يعد موافقة من حضرتكم بالسماح لمعامل البرج باستخدام البيانات الشخصية في الرسائل التذكيرية و في حالة الرفض او العدول عن تلك الموافقة الاتصال ب 19911

PET Scan
[[DOCTYPE:PET_SCAN]]

البـــرج
معامل و سكان

Visit No.:	42026503818	Patient Name:	الأستاذ / جمال الدين احمد محمود
Visit Date:	07 Apr 2026	Branch :	B-Hadayek Helwan
Receipt No.:	4367	Ref. Doctor:	ياسر محمد
Payment Date:	07-04-2026 15:44:54	Customer:	سنتاه مصر

Patient ID:	161624527		
Age / DOB:	71 year	/ 01 Jan 1955	
Result Date:	08 Apr 2026		
Insurance No	1111		

Item Type	Item Name	Value	Result Date
Test	PSA-Total	262.5	08 Apr 2026
Test	PSA-Free	437.5	08 Apr 2026

Current Receipt Amount:	700	Discount:	0
Payment User Name:	محمد جمال مزيد	Final Amount:	700
Payment Date Time:	4/7/2026 3:45:02 PM	Total Received:	700
		Balance Amount:	0

اجمالي المبلغ المدفوع : 700 جنيها

User ID : user_1B613624527
Password : ADCDE975

يتم تسوية حساب التحويلات خلال سبعة أيام من هذا الإيصال وذلك كحد أقصى يسقط بعده حق المطالبة باسترداد المبلغ وفي حالة التسويه يلتزم العميل باحضار التالي (خطاب التحويل - صورة البطاقة الشخصية للمريض او للوالد في حالة الطفل - هذا الإيصال)

لاستفساراتكم وخدمة الزيارة المنزلية وتوصيل النتائج اتصل بخدمة العملاء من اي تليفون على - 19911

استلام النتائج من اى فرع من فروع معامل البرج و من خلال الموقع الإلكتروني مجانا https://www.alborglab.com/web/alborg-lab/eservices#/results

كما يمكنكم ايضا أستلام النتائج عن طريق تحميل تطبيق - (البرج لاب - Alborg Lab)

العنوان : شارع خالد بن الوليد امام محكمه الاسره 18

تليفون : 23764326 - 23764325 - 01159433226

استلامكم لهذا الإيصال يعد موافقة من حضرتكم بالسماح لمعمل البرج باستخدام البيانات الشخصية في الرسائل التذكيرية و في حالة الرفض او العدول عن تلك الموافقة الاتصال بـ 19911

PET Scan
[[DOCTYPE:PET_SCAN]]

اسم الفـــرع حدائق حلوان
مدير الوحـده ا.د منال كمال
طبيب الوحده د. سها حامد

Visit Number:	42026503965	Registered	08-04-2026 15:52:35
Patient Name:	جمال الدين احمد محمود	Collected	08-04-2026 15:52:45
Age / Sex:	71 Year / Male	Authenticated	08-04-2026 22:40:34
Referred By:	Prof : ياسر محمد	Printed	10-04-2026 17:24:26
Client Name:	6116		

TEST NAME	RESULT	UNIT	REFERENCE RANGE
Liver Function Tests			
Serum Albumin	4.4	g/dL	3.5 - 5.2
Kidney Function Tests			
Ionized Calcium	1.17	mmol/L	1.12 - 1.32
Serum Calcium	9.4	mg/dL	8.6 - 10.2

Dr. Manal Kamal
Professor of Clinical & Chemical Pathology,
Faculty of Medicine, Cairo University

Lab Test
[[DOCTYPE:LAB_TEST]]

معامل البرج

بالتأكيد..

اسم الفـــرع حدائق حلوان
مدير الوحـــده ا.د منال كمال
طبيب الوحده د. سها حامد

Visit Number:	42026509074	Registered	27-07-2026 18:41:32
Patient Name:	جمال الدين احمد محمود	Collected	27-07-2026 18:41:44
Age / Sex:	72 Year / Male	Authenticated	28-07-2026 12:00:32
Referred By:	Prof : ياسر محمد	Printed	29-07-2026 11:38:49
Client Name:	6116		

TEST NAME	RESULT	UNIT	REFERENCE RANGE
Tumor Markers			
PSA Total	6.330	ng/mL	0 - 6.5

Assay Method: ECLIA
*Screening Testing on Asymptomatic men :
PSA Screening may be carried out every two years.
An Alternative is Annual Testing for PSA levels above 2.5 ng/ml.(American Cancer Society ,2016)
Results determined by using different methods may not be comparable.

PSA Free	1.470	ng/mL	
Assay Method: ECLIA			
PSA Ratio	L 0.232		Normal : More Than 0.25
Assay Method: ECLIA			

Dr. Manal Kamal
Professor of Clinical & Chemical Pathology,
Faculty of Medicine, Cairo University

1-1

Scan Me

خصم 30% على جميع أنواع الأشعة لفترة محدودة لا يسري مع التعاقدات ولا أي خصومات أخرى

1991
elborglab.com

[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]
Pathology Report

Prof. Of Pathology
Faculty of Medicine, Cairo University
Fellow, Ohio State University U.S.A.

أستاذ الباثولوجيا
كلية طب قصر العيني
زميل جامعة أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية

Name: جمال الدين أحمد محمود صقر **Age:** 68 years

Clinical Diagnosis: Large prostate with large irregular heterogeneous mass. Total PSA= 40.400 ng/dl. Free PSA= 12.900 ng/dl.

Nature of specimen: TRUS guided prostatic biopsies.

Referred By : Prof. Dr. HATEM SULTAN. **Date:** 11/08/2021

PATHOLOGY REPORT

GROSS: Specimen received consists of six prostatic needle T.R.U.S. guided biopsies from: 1. Right apex. 2. Right mid-prostate. 3. Right base. 4. Left apex. 5. Left mid-prostate. 6. Left base. Each specimen is formed of one or two grayish white cores. All specimens were submitted totally and serially sectioned.

MICROSCOPIC: Serial sections examined from **specimen (1) (right apex)** revealed a fibromuscular core of prostatic tissue showing focal mild perivascular lymphoplasmacytic infiltrate. Portions of skeletal muscle were detected. Serial sections examined from **specimen (2) (right mid-prostate)** revealed a core of prostatic tissue showing fibromuscular stroma infiltrated by tumour tissue formed of cribriform structures and cords of cubical epithelial cells showing enlarged hyperchromatic or vesicular pleomorphic nuclei having prominent nucleoli with mild mitotic activity. Tumour tissue constituted about 30% of the core examined. Serial sections examined from **specimen (3) (right base)** revealed a core of prostatic fibromuscular stroma infiltrated by tumour tissue formed of irregular; focally fused; glands lined by a single cell layer of cubical epithelial cells showing enlarged vesicular nuclei having prominent nucleoli. Cribriform structures and solid groups formed of these cubical cells were also detected. Perineural invasion by tumour tissue was also seen. Tumour tissue constituted about 50% of the core examined. Serial sections examined from **specimen (4) (left apex)** revealed a core of prostatic tissue showing fibromuscular stroma with focal areas of atrophy and cystic atrophy. Serial sections examined from **specimen (5) (left mid-prostate)** revealed two cores of prostatic tissue showing variable sized hyperplastic glands lined by double cell layer; inner cubical and outer basal; with moderate infoldings. The surrounding fibromuscular stroma is hyperplastic. Focal areas of atrophy and cystic atrophy were also detected. Serial sections examined from **specimen (6) (left base)** revealed a core of prostatic tissue showing hyperplastic glands surrounded by hyperplastic fibromuscular stroma. Focal areas of atrophy and cystic atrophy were also detected.

DIAGNOSIS: Prostate, TRUS guided prostatic biopsies:

1. **Right apex: Fibromuscular core.**
2. ***Right mid-prostate, Prostatic Adenocarcinoma, Gleason 4+5.***
3. ***Right base, Prostatic Adenocarcinoma, Gleason 4+5.***
4. ***Left apex, Focal Atrophy And Cystic Atrophy.***
5. **Left mid-prostate, Prostatic Hyperplasia, Focal Atrophy And Cystic Atrophy.**
6. **Left base, Prostatic Hyperplasia, Focal Atrophy And Cystic Atrophy.**

CONCLUSION: Poorly Differentiated (High Grade) Prostatic Adenocarcinoma, Gleason 4+5=9, Associated With Prostatic Hyperplasia, Focal Atrophy And Cystic Atrophy.

Thanks for reference,

1 ميدان الحرية – الدور الأول – المعادى – ت 25254562 ميدان البحيرة – 2 شارع طلعت حرب – الدور الثالث – ت 25749601

11/8/2021